

Fecha Última Actualización: 24-12-2024 1:37:15

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Maria Gabriela Alfaro Castro
Edad : 67a 1m 23d
Dirección : Pasaje Sistina 1639

Rut : 8.378.493-8
Fecha Nacto: 01/11/1957
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1216959
Sexo : Femenino
Teléfono : 987435829

N° Epicrisis
425104

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Cirugía Sector A - Alta Complejidad

Fecha Ingreso : 22/10/2024 01:10

Días Estadía: 63

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 24/12/2024 01:12

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Compromiso del estado general

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

FI CASR: 22/10/2024
FI Cx A: 26/10/2024
FI UCI: 19/11/2024
TQT Pc: 17/12/2024
ATB: Vancomicina 1gr c/48hr EV (05/12) SAMR.

Fluconazol 200mg c/día EV (29/11) Candida Albicans. termina el (26/12) 14 días
Vancomicina 1gr c/48hr EV Cubrimiento (23/11) SAMR FI (05/12) x Trombocitopenia se suspendio Line.
Cefta/Avibactam 1.25gr c/dia EV (20/11) KPN BLEE KPC.
Aztreonam 2gr c/dia EV (20/11)KPN BLEE KPC.

DIAGNÓSTICOS:

1. SHOCK SÉPTICO:

a. Sepsis foco osteoarticular femur/rodilla izquierda en tratamiento:
2. OSTEOMIELITIS PERIPROTÉSICA DE LA DIÁFISIS DISTAL DEL FÉMUR/INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA/
ARTRITIS SÉPTICA RODILLA IZQUIERDA POR SAMR, KPC, Candida Albicans.

a. Artritis séptica de rodilla izquierda por K. pneumoniae KPC

b. Osteomielitis de fémur izquierdo por E. cloacae

c. Osteomielitis de tibia izquierda por Cándida albicans MS

d. Sepsis foco cutáneo con colección pinchada y aseada

** Aseo Qx 6Lt + Cambio de clavo endomedular izq con antibiótico + Drenaje articular rodilla izq (12/12)

¿ CC Hematoma Rodilla izq/Muslo: Candida Albicans (12/12)

3. SHOCK HEMORRÁGICO RESUELTO

a. HDA¿ EDA úlcera gastroduodenal Forrest IIa (02/12)

** Inyectoterapia + Clip 02/12

4. AKI KDIGO III EN OLIGOANURIA

a. Anasarca

b. HD de agudo.

5. DESNUTRICIÓN CP SEGÚN CRITERIOS DE GLIM:

6. IAM TIPO II

Fecha Epicrisis : 24/12/2024 01:37

Página 1 de 2

Fecha Última Actualización: 24-12-2024 1:37:15

Página 2 de 2

Antecedentes: HTA, DM2, ERC etapa III (crea basal 1.4), Dislipidemia y Obesidad

IMÁGENES:

** 21/12: TAC CEREBRO: Pendiente informe por radiología.

** 21/12: TAC TAP: Bandas atelectásicas subsegmentarias en ambas bases pulmonares. sin focos de condensación, Leve derrame pleural derecho. Cánula de TQT in situ. DHC por nodularidad de sus contornos, ensanchamiento cisternal e hipertrofia del lóbulo caudado con ascitis difusa como Hipertensión portal. Mioma calcificado corporal lateralizado a derecha de 43 mm. Leve ascitis de predominio en la excavación pelviana. Moderado a acentuado edema celular subcutáneo de la pared toracoabdominal, hallazgo que se extiende al tercio proximal de ambos muslos

MICROBIOLOGÍA:

** 20/12: Caet: (-) UC: Enterococcus faecium >100mil ufc. P/: HC I/II/CVC/UC.

** 12/12: CC Hematoma Rodilla izq/Muslo: Candida Albicans. S: Anfo B0.5, Fluco <0.5, Micaz0.06 Vori<0.12.

EVOLUCIÓN DURANTE HOSPITALIZACIÓN

Paciente con shock séptico foco cutáneo y óseo por osteomielitis e infección de sitio operatorio evoluciona a la fecha con HD inestable dependiente de DVA NAD 0.06 mcg/kg/min febril persistente hasta 38.3C. FC112X. Revisamos cultivos con jefatura de módulo y dado cuadro clínico de pacient, laboratorio y cultivos 20/12/24 (+) urocultivo para E.faecium VAN B Sensible a Linezolid, sedecide ajuste de atamiento antibiótico dirigido para Infección del tracto urinario.

En paralelo se solicita nueva Interconsulta a TMT para evaluar si sepsis actual corresponde a foco osteoarticular vs urinaria (ambos con cobertura antibiótica dirigida por cultivos). Se deicde nueva imagen para evaluación de nuevo pabellón

Paciente va a Scanner a 19:15 hrs. A su regreso evoluciona con PCR, con orden de no RCP la cual fue definida previamente por familiares junto a jefatura de modulo.

Fallece paciente a las 20:30 hr. Me comunico con familiares quienes acuden en forma presnecial a HSR.

Entrego información presencial a hija (tutora) junto a familiares, entienden el suceso y pasos a seguir.

Diagnóstico de Egreso

Sepsis - Sepsis de foco osteoarticular

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallece paciente 20:30 hrs

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

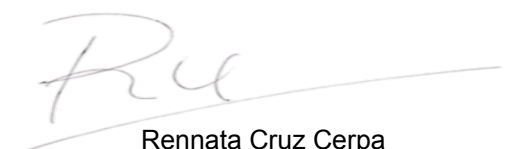
Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente


Rennata Cruz Cerpa
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 24/12/2024 01:37

Página 2 de 2

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:41

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar